АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПСОРИАЗА

М.И. Адильгереева[1]

В статье включены данные литературного анализа по аспектам псориаза, которые имеют важное значение у медиков особенно у дерматологов, а также изучения этой проблемы остается открытым вопросом.

Ключевые слова: заболевание, осложнения, зуд, кожа, аспекты.

Распространенные хронические заболевания, в этиологии которых существенную роль играет генетическая компонента, но характер наследования не может быть объяснен простыми менделевскими правилами, образуют группу многофакторных заболеваний. Такие патологии в настоящее время приобретает все большее значение для медико-генетического консультирования и практического здравоохранения, так как в среднем около 10% населения страдает болезнями с наследственной предрасположенностью, а их доля среди общего числа случаев наследственной патологии человека достигает 90%.

Специалистами утверждено, что примером многофакторного заболевания, когда изменчивость того или иного признака определяется не одним главным геном, а влиянием большого числа генетических и внешне средовых факторов, является псориаз. Псориаз - один из наиболее распространенных хронических воспалительных дерматозов, характеризующийся гиперпролиферацией эпидермиса и нарушением кератинизации.

Статистика показала, что псориазом страдают 0,3-7 % населения во всем мире. Согласно последним данным Международной Организации Псориаза 125 миллионов людей в мире имеют псориаз. Псориаз представляет собой системный процесс с выраженными функциональными и морфологическими изменениями ряда органов и систем организма. У больных псориазом наблюдаются проявления нарушений функций центральной, периферической и вегетативной нервной системы, эндокринных желез, метаболические изменения, особенно выраженные при остром и распространенном псориазе. Приблизительно у 15-40% больных псориазом развивается псориатический артрит, часто с множественным поражением суставов, приводящих нередко к инвалидизации, что в значительной степени усугубляет качество жизни больных. По меньшей мере, у 30% больных, имеющих псориаз наряду с другими серьезными заболеваниями, такими как депрессия, заболевания сердечно-сосудистой системы и диабет, отмечена склонность к суицидам. В связи со значительной распространенностью заболевания, хроническим и зачастую, тяжелым течением, несовершенством имеющихся методов лечения, неясностью этиологии и патогенеза, проблема псориаза является одной из актуальных в медицине.

Дальнейший анализ литературных данных показал, что несмотря на длительную историю изучения псориаза, этиология и патогенез заболевания окончательно не выяснены, что значительно затрудняет разработку оптимальных и эффективных методов терапии и возможность добиться длительной клинической ремиссии. В настоящее время признана точка зрения, согласно которой псориаз является многофакторным заболеванием, на развитие которого влияют как генетические факторы, так и факторы внешней среды (травматические, нервно-психические, применение некоторых медикаментов, злоупотребление алкоголем, курение, инфекционные заболевания и т.д.). Генетические факторы доминируют над средовыми, о чем свидетельствуют высокие значения коэффициента наследуемости псориаза. Вместе с тем средовая компонента, играя определенную роль в возникновении дерматоза, оказывает значительное влияние на характер течения и прогноз уже развившейся болезни.

[1]*Адильгереева Мадина Искандеровна* – ассистент кафедры кожных и венерических болезней, детских кожных и венерических болезней, СПИД, Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан.

Как отмечено в литературных источниках, что в настоящее время псориаз остается одним из наиболее часто встречающихся дерматозов, поражая около 5% человеческой популяции. Общепризнано, что иммунопатогенез псориаза в значительной мере заключается в развитии гиперпролиферативных процессов в эпидермисе протекающих с нарушением дифференцировки кератиноцитов и сочетающихся с воспалительной реакцией в дерме. Анализ литературных данных дает основания полагать, что у больных псориазом иммунные нарушения могут прослеживаться как на системном уровне, так и в пораженной коже. Выявлены существенные нарушения в системе клеточного иммунитета. Снижение иммунорегуляторного индекса, прослеживающееся у больных псориазом, характеризуется как «псориатический фенотип» пациента. Иммуноморфологическими методами обнаружены аутоантитела к фибробластам и кератину, что свидетельствует об аутоиммунном компоненте в генезе псориаза. Выявленные разнообразные нарушения в системе нейтрофильных лейкоцитов характеризовались нарушениями хемотаксиса, и способности миграции в пораженную кожу. Высокая экспрессия ИЛ-12 и ФНО - а в очагах поражения, по мнению ряда авторов, свидетельствует об иммунноопосредованном характере псориатического процесса.

А в свою очередь клиницистами отмечено, что с тем в каскаде иммунопатологических реакций способствующих возникновению псориаза и последующей хронизации его течения не ясна роль нарушений V цитокинопосредованных межклеточных взаимодействий иммунокомпетентных клеток. Между тем стремление к более детальной разработке иммуногенеза псориаза обусловлено необходимостью поиска более рациональных методов его лечения. Традиционная терапия, включающая применение витаминов, препаратов кальция, иммуносупрессантов, топических стероидов и др. во многих случаях, особенно при прогрессирующих, захватывающих обширные участки кожных покровов формах заболевания не оказывает желательного терапевтического эффекта. Кроме того, применение циклоспорина и ремикейда сопряжено с возможностью возникновения серьезных побочных эффектов, в том числе системного иммунодефицита.

Таким образом, проведенный' анализ отечественной и зарубежной литературы свидетельствует целесообразности дальнейшего изучения иммунопатогенеза псориаза и разработки на этой основе новых более рациональных подходов к его лечению.

Статистические данные показали, что псориазом страдает в среднем до 3% населения земного шара, т.е. около 80 млн. человек, причем с одинаковой частотой женщины и мужчины. Отдельные авторы указывают на некоторое превалирование мужчин среди больных псориазом. Так, во Франции псориаз регистрируется у 5,8% мужчин и 3,5% женщин, в Испании у 2,8% населения страны. В России среди стационарных больных дерматологических отделений на долю псориаза приходится от 6,5% до 22% случаев, а среди всех больных дерматологического профиля – 5%. Заболеваемость псориазом в Уральском Федеральном округе на 2011 гг. составила 79,2 на 100 тыс. населения, в Российской Федерации 69, 8 на 100 тыс. населения. Отмечается патоморфоз псориатического процесса в последнее десятилетие: заболевание все чаще возникает в молодом возрасте, отличается торпидностью течения, более частым развитием тяжелых форм, нередко приводящих к инвалидизации, в частности, псориатического полиартрита, псориатической эритродермии, с выраженной резистентностью заболевания к терапии. Современные исследователи продолжают дебатировать вопрос о роли генетических факторов и факторов окружающей среды в развитии псориаза. Некоторые исследователи склоняются к доминирующей роли генетических факторов, выясняя особенности генетического кода. Важность генетической детерминанты в развитии псориаза была четко показана в ряде эпидемиологических исследований. Были выделены два типа псориаза, отличающиеся частотой ассоциации с антигенами HLA. Для I типа псориаза свойственно раннее начало заболевания (пик 16-25 лет), с положительной корреляционной связью с антигенами Cw6 – 85% и DR-7 – 70%. II тип характеризуется более поздним началом (пик на 5-м десятилетии жизни), связь с наследственностью - 1%, а частота аллелей – соответственно 14% и 30%. К настоящему времени установлено 8 локусов восприимчивости к псориазу, которые картированы на 8 хромосомах и обозначаются

PSORS1-8. Установлено, что локус PSORS1, расположенный на коротком плече 6-й хромосомы (6p21.3), является главным местом предрасположенности к псориазу, поскольку содержит несколько сцепленных генов, которые активно экспрессируются в кератиноцитах кожи. Данный локус представляет собой область, на которой расположены 5 генов (HLA-C, TCF19(SC1), OTF3 (POUF5F1), HCR (Pg8), CDSN), два из которых (HCR и CDSN) проявляют выраженную ассоциацию с псориазом. Среди известных эндогенных и экзогенных факторов окружающей среды наиболее частым и значимым был отмечен стресс - фактор дебюта и 15 аггравации псориаза, в органных проявлениях которого фундаментальную роль, по-видимому, играет состояние эндокринной системы, определяя патогенез заболевания. Психогенные воздействия при псориазе выступают в качестве звена в череде последовательных иммунологических событий и приводят к обострению дерматоза лишь в тесной связи с основными факторами патогенеза. В условиях стресса, каковым является заболевание, функционирование нервной, эндокринной и иммунной систем испытывает дисрегуляцию. Исследователями обсуждается возможность инфекционных агентов провоцировать заболевание кожи у генетически предрасположенных лиц, также индуцировать аутоиммунные процессы, приводя в ряде случаев к развитию артропатий и эритродермии. J. Prinz (1999) предположил ведущими триггерными факторами дебюта псориаза пиогенный стрептококк, бета-гемолитический стрептококк, большая часть которых относится к группе А, подчёркивая ведущую роль в патогенезе псориаза CD4+ и, в меньшей степени, CD8+ клеток, что было подтверждено в более поздних исследованиях.

Дальнейший анализ литературных данных показал, что в настоящее время в патогенезе псориаза иммунный механизм рассматривается ведущим, вне зависимости от возможных пусковых механизмов. Нарушения иммунной системы у больных псориазом выявляются как на клеточном, так и на гуморальном уровне и заключаются в изменениях содержания иммуноглобулинов основных классов, циркулирующих иммунных комплексов, пула лимфоцитов в периферической крови, В- и Т-популяций и субпопуляций лимфоцитов, клеток-киллеров, фагоцитарной активности сегментоядерных лейкоцитов.

Авторами зарубежной и отечественной литературы отмечен тот факт, что патофизиологически псориаз характеризуется воспалительной реакцией, гиперкератозом, нарушенной дифференцировкой эпителиоцитов, активацией иммунной регуляции кератиноцитов, связанной с продукцией цитокинов. Более поздние исследования привели к дальнейшему подтверждению псориаза не только «заболевания кожи», а «Т-клеточного заболевания». Роль Т клеток в псориатической патологии демонстрирует высокую степень системного воспалительного процесса, в частности, Т-хелперов Th-1, Th-17 и Th-22 клеточных популяций. При стимулировании лимфоцитов высвобождаются воспалительные цитокины, такие как фактор некроза опухоли (TNF-a, TNF-β), интерлейкины (IL-17 и IL-22). Цитокины в настоящее время относят к наиболее перспективным маркерам нарушения процессов иммунорегуляции при воспалительных заболеваниях, особую роль играют интерлейкины – IL-2, IL-6, IL-8, IL-10; фактор некроза опухоли-α и β (ФНО-α, - β); интерферон-γ (ИФН-γ). Системность проявлений псориаза, тяжесть течения псориатического процесса обуславливает актуальность дальнейшего уточнения патогенеза данного дерматоза. Многочисленные исследования последнего времени показали важную роль системной воспалительной реакции (СВР) в патогенезе псориаза. Основными проявлениями СВР являются гиперцитокинемия, острофазный ответ, появление в системном кровотоке продуктов активации лейкоцитов и системы комплемента. Эти предпосылки дают основание для рассмотрения патогенеза псориаза с 17 позиции системного воспаления как самостоятельного типового патологического процесса, по ряду своих атрибутов отличающегося от классического воспаления и также имеющего обозначенные выше признаки СВР. Одними из ведущих провоспалительных цитокинов, характеризующих активность системного воспаления, является ФНО-α и ФНО-β.

ФНО-α и β - стимулируют адгезивные молекулы эндотелия, повышают их синтез эндотелиальными и гладкомышечными клетками, способствуя тем самым проникновению воспалительных клеток в сосудистую стенку. ФНО-α и β

уменьшают образование оксида азота, что угнетает дилатацию сосудов и способствует дисфункции эндотелия. Кроме того, ФНО-α повышает уровень свободных жирных кислот, что благоприятствует как инсулинорезистентности, так и формированию атерогенного липидного профиля. ИЛ-6 также участвует в патогенезе СВР, и ведущее значение в механизме его патогенетического действия принадлежит развитию инсулинорезистентности за счет прерывания внутриклеточного сигнального пути инсулина, кроме того, он стимулирует продукцию триглицеридов. У больных гипертонией найдена тесная коррелятивная связь функционального состояния эндотелия и содержания ФНО-α и ИЛ-6 в крови, на основании чего был сделан вывод, что эти цитокины играют важную роль в развитии системного воспаления. Выявлена обратная корреляция между толщиной интимы сонной артерии и содержанием ИЛ-1 в крови. Сообщалось об отрицательной корреляции между продукцией ИЛ-1 и секрецией растворимой фракции эндотелиальных адгезивных молекул. Интерферон-гамма (IFN-γ), секретируемый Т-клетками, макрофагами, гладкомышечными клетками сосудов, играет роль в патогенезе СВР. IFN-γ стимулирует в макрофагах секрецию ФНО-α и ИЛ-6 и действует 18 синергично с ними, стимулируя продукцию металлопротеиназ, реактивных форм кислорода, факторов роста.

Таким образом, опираясь на данные литературы можно отметить,что необходимо уточнение факторов, влияющих на иммунопатогенез псориатической болезни, его звенья, что необходимо для разработки эффективной терапии псориаза,а также значительная распространенность, увеличение числа больных с тяжелыми торпидно протекающими формами заболевания, неясность многих патогенетических звеньев и несовершенство применяемых методов лечения позволяют отнести псориаз к наиболее значимым медико-социальным проблемам современной дерматологии.

Список литературы:

1. 1.Хубутия М.Ш. Гомоцистеин при коронарной болезни сердца и сердечного трансплантата: монография / М. Ш. Хубутия, О.П. Шевченко. - М.: Реафарм. - 2004. - 271 с.
2. Хышиктуев, Б.С. Вариабельность количественных изменений жирных кислот с короткой цепью в сыворотке крови и эпидермисе при псориазе/ Б. С. Хышиктуев, Т.М. Караваева, Е. М. Фалько // Клиническая лабораторная диагностика: Ежемесячный научно-практ. журнал. - 2008. - №8. - С. 22-24.
3. Шахова А.С. Сранительный анализ эффективности низкоинтенсивного лазерного излучения и ПУВА-терапии в лечении псориаза / А. С. Шахова, А. Г. Куликов, А.В. Герцен [и др.] // Физиотер., бальнеол. И реабил. – 2010. - № 4. – С. 16-20.
4. Ширинский И.В. Опыт применения симвастатина при вульгарном псориазе. / И. В. Ширински и др. //Вестник дерматологии и венерологии. - 2009. - №5. – С. 88-90.
5. Шварц В.Я. Воспаление как фактор патогенеза инсулинрезистентности и сахарного диабета 2-го типа / В. Я Шварц // Терапевтический архив.- 2009.- № 10. -С. 74-80.
6. Шварц В. Я. Жировая ткань как эндокринный орган/ В. Я. Шварц // Проблемы эндокринологии. - 2009. - Т. 55 - № 1. - С. 38-44.
7. Шварц В.Я. Воспаление жировой ткани и атеросклероз / В. Я. Шварц // Кардиология.- 2009. - Т. 49 - № 12. - С. 80-86.
8. Alexa B. Increased Risk of Psychiatric Disorders in a Pediatric Population with psoriasis / B. Alexa, Kimball, Annie Guerin, Andrew P. Yu, Eric Q. Wu et al. // 2- nd World psoriasis & Psoriatic arthritis conference. - 2009, Stockholm. - p.10.
9. Archier E. Carcinogenic risks of psoralen UV-A therapy and narrowband UV-B therapy in chronic plaque psoriasis: a systematic literature review/ E. Archier // JEADV. - 2012. – 3.– P.22-31.
10. Pahau H. Cardiovascular disease is increased prior to onset of rheumatoid arthritis but not osteoarthritis: the population-based Nord-Trondelag health study (HUNT) / H. Pahau, M. A. Brown, S. Paul et al. // Arthritis. Res. Ther. – 2014.
11. (2). 193. Parisi R. Global epidemiology of psoriasis: a systematic review of incidence and prevalence / R. Parisi // J Invest Dermatol. – 2013. - 133(2). - 377-85. 13. Pereira M.G. Dyadic adjustment, family coping, body image, quality of life and psychological morbidity in patients with psoriasis and their partners / M. G. Pereira, 14.L. Brito, T.

Smith // Int. J. Behav. Med. - 2011. - Jun 25. 195. Phillips C.M. Additive effect of polymorphisms in the IL-6, LTA, and TNF- {alpha} genes and plasma fatty acid level modulate risk for the metabolic syndrome and its components / C. M. Phillips, L. Goumidi, S. Bertrais // J. Clin. Endocrinol. Metab. - 2010. – 95. – P. 1386–1394
12. Warnecke C. Cardiovascular and metabolic risk profile in German patients with moderate and severe psoriasis: a case control study / C. Warnecke, I. Manousaridis, R. Herr // Eu. J. Dermatol. - 2011. – 21. – P. 761–770.
13. Wilson F. C. Incidence and clinical predictors of psoriatic arthritis in patients with psoriasis: population-based study / F. C. Wilson // Ac.AR. - 2009. – 52(4). – P.574.
14. Wolberink E.A. Cellular features of psoriatic skin: imaging and quantification using in vivo reflectance confocal microscopy / E. A. Wolberink, P. E. van Erp, M. M. Teussink et al. // Cytometry. Clin. Cytom. - 2011. - 80(3). - 141-9
15. Sahin E. Adiponectin levels, insulin resistance and their reletionship with serum levels of inflammatory cytokines in patients with Behcets disease / E. Sahin // JEADV. - 2012. – 12. – P. 1498-1502. 143
16. Saremi A. Association between IL-6 and the existent of coronary atherosclerosis in the veterans affairs diabetes trial (VADT) / A. Saremi, R. J. Anderson, P. Luo // Atherosclerosis. – 2009. – V. 203. - P. 610-614.
21. Setty A.R. Obesity, waist circumference, weight change, and the risk of psoriasis in women: Nurses' Health Study II / A. R. Setty, G. Curhan, H. K. Choi // Arch. Intern. Med. - 2007. - 167. - 1670-1675.

© М.И. Адильгереева, 2022.